

Le Nevrosi — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 07

Hai già letto il dettagliato? Bene. Qui si ripassa. Questo è il materiale che ti serve fresco in testa prima dell'esame — cinque minuti e sei pronto.

Definizione e storia

- **Nevrosi** = disturbo psichico senza causa organica; espressione simbolica di un conflitto tra desiderio e regola
 - La teoria delle nevrosi coincide con la nascita della **psicoanalisi**
 - **William Cullen** (fine '700): primo a usare il termine per malattie senza origine somatica
 - **Tre tappe storiche**: Pinel (trattamento morale) → Charcot (natura psicologica, ipnosi) → Freud (dinamica inconscia, libere associazioni)
 - Dal DSM-III in poi: il termine "nevrosi" scompare, sostituito da diagnosi specifiche (disturbi d'ansia, DOC, PTSD, disturbi somatici...)
 - Conseguenza: nasce il concetto di **comorbidità** — più diagnosi per la stessa persona, rischio di perdere il filo della storia
-

Tra normalità e patologia

- Tutti possiamo avere pensieri o comportamenti nevrotici occasionalmente
 - Diventa patologia quando sono presenti tutti e tre i criteri:
 - **Durata**: persiste nel tempo (es. da almeno 6 mesi)
 - **Intensità**: si manifesta più volte al giorno, non è sporadico
 - **Compromissione**: intacca lavoro, relazioni, vita quotidiana
-

Caratteristiche del disturbo nevrotico

- **Esame di realtà mantenuto:** la persona riconosce la realtà (differenza fondamentale con la psicosi)
 - **Sintomo egodistonico:** la persona è *consapevole* dell'irrazionalità dei propri sintomi → chiede aiuto più facilmente
 - Comportamento inappropriato rispetto al problema; la persona vede tutto attraverso "occhi nevrotici" — tutto è insormontabile
 - Aree colpite: autostima, umore (ansia, depressione, irritabilità), sonno, relazioni, sintomi somatici
-

Struttura nevrotica (Bergeret)

- **Struttura** = modo di funzionamento profondo della personalità; non è patologia di per sé
- Due strutture principali: **nevrotica** vs **psicotica**; nel mezzo l'organizzazione limite
- Lo **scompenso** (crisi/rottura) trasforma la struttura in patologia
- Diagnosi di struttura solo in **età adulta**; l'adolescenza è l'ultimo momento possibile per un cambio di struttura (raro)
- I sintomi sono **trasversali**: stessa sintomatologia può appartenere a strutture diverse → non si diagnostica solo dai sintomi

Caratteristiche struttura nevrotica

Elemento	Caratteristica
Istanza dominante	Super-Io (regole)
Conflitto	Edipico (Super-Io vs Es)
Angoscia	Di castrazione
Relazione	Genitale (l'altro è una persona reale)
Difesa principale	Rimozione

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)

- Luogo del sintomo: il **pensiero**
- Due sintomi principali: **ossessioni** + **compulsioni**

Ossessioni

- Pensieri/immagini/impulsi **non voluti**, incontrollabili, incongruenti con i propri valori
- Categorie: contagio, responsabilità del danno, simmetria/ordine, sessuali, violenza/aggressione, religione
- Tre caratteristiche: non desiderate e incontrollabili / incongruenti con i valori / la persona tenta di resistere

Compulsioni

- Rituali (lavarsi le mani, controllare, riordinare) o azioni mentali (contare, pregare) per **ridurre l'ansia** ossessiva
- Danno **solievo**, non piacere (solievo = allontanamento dal disagio; piacere = movimento verso qualcosa di gradito)
- DSM-5-TR: più di 1 ora/giorno o compromissione del funzionamento
- Elemento aggiuntivo: **evitamento** di situazioni che innescano ossessioni/compulsioni

Meccanismi di difesa nel DOC (secondari/maturi)

- **Rimozione**: impulsi inaccettabili → coscienza; riemergono come ossessioni
 - **Formazione reattiva**: affetto negativo → polo opposto (es. pensiero blasfemo → rituale religioso)
 - **Spostamento**: ansia spostata dall'ossessione a un rituale più controllabile
 - **Isolamento**: componente affettiva separata da quella cognitiva
 - **Annullamento retroattivo**: comportamento che "cancella" simbolicamente pensieri/azioni precedenti
-

La nevrosi isterica

- Luogo del sintomo: il **corpo**
 - Termine da *hystéra* (utero) — storia lunga: da movimenti uterini a possessioni demoniache a psicogenesi
 - **Charcot**: quattro fasi della crisi — epiletoide, contorsioni (posizione ad arco), allucinatoria, delirio
 - **Freud**: libere associazioni; conflitto si esprime attraverso sintomi fisici (**conversione**)
 - **Conversione**: conflitto psichico irrisolto trasferito sul corpo
 - **Isteria d'angoscia**: quando la rimozione non basta → ansia spostata su un oggetto → **fobia**
 - Nel DSM-5-TR: distribuita tra disturbi dissociativi, disturbi somatici, disturbi d'ansia (fobia specifica)
-

Ruolo dell'operatore sociale con il DOC

- No registri moralistici
 - Non vietare le compulsioni (aumenta l'ansia)
 - Lavorare sulla condizione che genera l'ansia, non direttamente sul sintomo
 - Creare un ambiente familiare e rassicurante riduce già la sintomatologia
-

Da ricordare: - Nelle nevrosi il sintomo è sempre **egodistonico** (consapevolezza) — sarà chiesto all'esame - La **struttura** non è patologia: lo diventa solo con lo **scompenso** - DOC: luogo del sintomo = pensiero; Isteria: luogo del sintomo = corpo